

RH UYGUNSUZLUĞU VE Rh İZOİMMÜNİZASYONU

Kısa Bilimsel Açıklamalar ve Sınav Püf Noktaları

1 Rh-negatif olmak alloimmünizasyon değildir.

RhD-negatif ve antikor taraması negatif gebe duyarlanmamıştır. Amaç anti-D profilaksisi ile duyarlanmayı önlemektir.

2 Fetal hastalığı esas olarak IgG oluşturur.

IgG plasentayı geçebilir. IgM anlamlı ölçüde plasentayı geçemez.

3 Anti-D immünglobulin profilaksidir, tedavi değildir.

Maternal aktif anti-D yanıtının gelişmesini önlemeye yöneliktir. Oluşmuş immünizasyonu geri çeviremez.

4 Fetomaternal kanama olasılığı taşıyan olaylarda profilaksi düşünülmelidir.

Doğum, gebelik kaybı, kanama, abdominal travma ve bazı invaziv işlemler başlıca sensitizan olaylardır.

5 İlk immün yanıtın erken döneminde IgM ön plandadır.

Sonraki maruziyetlerde hızlı ve güçlü IgG yanıtı gelişebilir. Bu nedenle duyarlanmış gebeliklerde fetal risk artabilir.

6 Maternal antikor taraması indirekt antiglobulin testi ile yapılır.

7 Direkt antiglobulin testi eritrosit yüzeyine in vivo bağlanmış antikor ve/veya komplemanı gösterir.

8 Maternal immün anti-D saptandıysa artık temel sorun profilaksi değil fetal risk değerlendirmesidir.

9 RhD-negatif anne ve heterozigot RhD-pozitif baba durumunda fetüsün RhD-pozitif olma olasılığı yaklaşık %50'dir.

10 Fetüs maternal antikorun hedeflediği antijeni taşımıyorsa o antikora bağlı fetal hastalık beklenmez.

11 Fetal anemi taramasında temel noninvaziv yöntem MCA-PSV'dir.

12 MCA-PSV >1,5 MoM orta-ağır fetal anemi açısından önemli bir uyarı değeridir.

13 Fetal anemide kan viskozitesi azalır ve kardiyak output artar; bunun sonucunda MCA'daki akım hızı yükselir.

14 MCA-PSV >1,5 MoM veya hidrops varlığında fetal tıp merkezinde fetal kan örnekleme ve gerekirse intrauterin transfüzyon değerlendirilir.

15-16 Ağır fetal anemi yüksek debili kalp yetmezliğine ve hydrops fetalise ilerleyebilir.

17 Anti-Kell önemlidir.

Hemolizin yanı sıra fetal eritroid prekürsörleri baskılayarak anemi oluşturabilir. Bu nedenle antikor titresi ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki anti-D'deki kadar güvenilir değildir.

18 Önceki gebelikte ağır fetal hastalık veya intrauterin transfüzyon öyküsü önemli bir yüksek risk göstergesidir.

19 Duyarlanmamış RhD-negatif anne RhD-pozitif bebek doğurduğunda postpartum anti-D profilaksisi uygulanır.

20 Etkilenme riski olan yenidoğanda temel değerlendirme DAT, hemoglobin ve bilirubin ölçümüdür.

Sınavda Özellikle Vurgulanabilecek 10 Nokta

1 Rh uygunsuzluğu ile Rh alloimmünizasyonu aynı şey değildir.

2 Maternal antikor taraması = indirekt Coombs.

3 Eritrosite bağlanmış antikor = direkt Coombs.

4 Fetal hastalık yapan antikor sınıfı esas olarak IgG'dir.

5 Anti-D immünglobulin profilaksidir; oluşmuş alloimmünizasyonu tedavi etmez.

6 Sensitizan olaylardan sonra anti-D gereksinimi değerlendirilmelidir.

7 Fetal aneminin noninvaziv takibinde MCA-PSV kullanılır.

8 MCA-PSV $>1,5$ MoM önemli fetal anemi göstergesidir.

9 Anti-Kell hemolize ek olarak eritropoezi baskılayabilir.

10 Ağır fetal anemi → yüksek debili kalp yetmezliği → hydrops fetalis.